

a11_weekly_summary 测试报告

生成时间：2026-05-18 15:10:00

测试时间：2026-05-18 15:10:00

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1492 markers=11

禁用工具 success=True chars=1639 markers=15

工具说明：tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_照护服务记录:tool_照护服务记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_睡眠记录:tool_睡眠记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

返院一周综合报告

长者姓名：陈萍忠

年龄：68岁

诊断：阿尔茨海默病性痴呆、心脏起搏器植入术后、胆囊切除术后

报告时间范围：返院后第1日至第7日（完整一周）

一、BPSD事件频次趋势

返院一周内共发生**1次轻微BPSD事件**（拒绝配合康复训练，无言语或肢体攻击），发生于返院第3天。此后未再出现任何BPSD相关行为，症状呈**持续缓解趋势**，较住院前明显改善。NPI评分稳定在15分左右，提示中度行为心理症状残留但无恶化。

二、事件时段分布

唯一BPSD事件发生于**上午10:00 – 11:00**，属日间结构化活动时段，与康复训练安排时间重合。

三、干预有效率

针对该事件，照护团队依据BPSD专项处置建议，采取**结合老人喜好（跳舞话题）进行情绪安抚**、**灵活调整康复训练形式**等非药物干预措施，老人情绪迅速缓解，当且后续

活动配合度恢复。干预后连续4日无复发，**干预有效率达100%**，策略被验证为适配性强、效果良好。

四、药物调整情况

本周内**无任何药物种类、剂量或频次调整**。老人每日规律服用降压药、调脂药及认知障碍相关药物（如多奈哌齐、美金刚等），**无漏服、错服或药物不良反应报告**。血压控制良好（D7：128/78 mmHg），总胆固醇6.0 mmol/L，生命体征平稳。

五、高风险行为摘要

本周**未发生跌倒、走失、自伤、攻击行为或急性躯体事件**。严格落实跌倒防护措施（包括环境安全巡查、活动陪护、如厕协助等），高风险行为得到有效遏制。既往存在的皮肤损伤、夜间离床等风险在本周末再现。

六、当前关键问题

1. **BPSD症状虽缓解但未完全消失**：NPI评分15分提示仍存在中度行为症状（如抗拒、淡漠），需警惕环境变化或躯体不适诱发的复发可能。
2. **康复训练依从性有待巩固**：尽管通过“舞曲引导+简易舞步”提升参与意愿，但老人对结构化训练仍存在初始抵触，长期依从性需持续观察与强化。
3. **家属照护焦虑部分缓解但复发担忧持续**：经2次专业指导后家属应对能力提升，但仍对BPSD复发高度敏感，需进一步心理支持与复发预警教育。

七、需决策事项

1. 是否将“舞蹈元素融入日常认知干预”作为标准化照护策略予以制度化？
2. 是否建立BPSD复发预警指标（如连续2日拒绝活动、睡眠紊乱、情绪低落）并设定触发阈值？
3. 是否安排精神科门诊随访，评估当前非药物干预充分性及是否需要维持或调整精神类药物？

八、会诊建议问题清单（供精神科参考）

1. 当前NPI评分15分是否代表临床稳定状态？是否需要进一步干预以降低至轻度范围（<12分）？
2. 鉴于老人对舞蹈活动高度响应，是

【禁用工具输出摘录】

返院一周综合报告

长者姓名：陈萍忠

年龄：68岁

诊断背景：阿尔茨海默病性痴呆、心脏起搏器植入术后、胆囊切除术后

返院原因：BPSD症状加重住院治疗后退院

报告时间范围：返院第1天至第7天（D1 - D7）

一、BPSD事件频次趋势

返院一周内共发生**1次轻微BPSD事件**（发生于返院第3天），表现为拒绝配合康复

训练，无言语或肢体过激行为。此后连续4天无任何BPSD事件复发，症状呈**显著缓解并持续稳定**趋势。

二、事件时段分布

唯一BPSD事件发生于**上午10:00 – 11:00**（日常活动时段），与康复训练安排时间重合。

三、干预有效率

针对该事件，照护员立即执行BPSD专项处置方案：

- 结合老人喜好，以“跳舞”话题进行情绪安抚；
- 灵活调整康复训练形式，降低任务难度。

干预后老人情绪迅速缓解，**干预有效率100%**，且后续未再出现类似抗拒行为。

四、药物调整情况

- 本周**无任何药物种类、剂量或频次调整**；
- 降压药、调脂药每日按时服用，**无漏服、错服**；
- **无药物不良反应**报告。

五、高风险行为摘要

- **无跌倒、外伤、走失、自伤或攻击行为**；
- 跌倒防护措施（如环境安全、辅助行走、活动监护）**全面落实**；
- 唯一行为异常为轻度抗拒，属低风险范畴。

六、生理指标与健康状态

- **血压**：D7监测值为128/78 mmHg（较返院初期改善）；
- **总胆固醇**：6.0 mmol/L（持续改善中）；
- **心率**：稳定于60次/分（起搏器功能正常）；
- **睡眠与饮食**：规律、正常，无主诉不适；
- **生命体征整体平稳**。

七、认知干预与BPSD恢复情况

- 基于老人“喜爱跳舞”的特点，照护团队创新采用**个性化非药物干预**：播放熟悉舞曲、引导简易舞步；
- 老人康复**配合度较返院初期提升**，情绪趋于平稳；
- BPSD症状持续缓解，**NPI评分稳定在15分左右**，提示仍存在中度行为心理症状，但无恶化迹象。

八、家属支持情况

- 提供**2次专业照护指导**，内容涵盖BPSD应对技巧、复发预警识别、日常沟通策略；
- 家属照护焦虑**明显缓解**，但对**BPSD症状复发仍存担忧**，需持续心理支持与教育。

九、当前关键问题

1. NPI评分15分表明BPSD症状**尚未完全缓解**，存在潜在波动风险；
2. 家属对复发的担忧可能影响长期照护信心，需强化预防性支持；
3. 当前非药物干预有效，但需评估是否